

Caso 1

Hipótese clínica: síndrome de Bardet-Biedl (BBS) — fenótipo incompleto no caso fictício



Menino, 13 anos • fenótipo visual-metabólico-endócrino

Achados clínicos principais

- Visão: nictalopia, perda periférica e retinopatia pigmentar/ERG alterado
- Metabólico: obesidade troncular grave de início precoce
- Endócrino: hipogonadismo e atraso puberal marcado
- Neurodesenvolvimento: dificuldade de aprendizagem leve e ataxia discreta
- Ausentes no caso fictício: polidactilia e alterações renais iniciais

Padrão sindrômico

Combinação visual + obesidade + hipogonadismo sugere ciliopatia tipo BBS, mesmo quando sinais clássicos estão incompletos.

Diagnóstico genético confirmado

PACIENTE REAL

N36

GENE

BBS9

VARIANTE

c.1789+1G>A • perda de sítio doador de splice

ACMG

Patogênica

DRC NO ARTIGO

Estágio 1

Ponto didático

Não excluir BBS pela ausência de polidactilia: fenótipo pode ser variável e progressivo.



RN masculino • UTI neonatal por insuficiência respiratória

Achados clínicos principais

- Neurocrânio: encefalocele occipital volumosa e hipoplasia de estruturas cerebrais
- Renal: rins aumentados, displasia renal cística bilateral severa e azotemia
- Extremidades: polidactilia pós-axial bilateral nas mãos
- Respiratório: insuficiência respiratória grave, ventilação mecânica e prognóstico reservado
- Outros: abdome distendido, oligúria, hipospádia e dismorfias faciais discretas

Padrão sindrômico

Tríade encefalocele + rins císticos + polidactilia aponta para ciliopatia letal do espectro Meckel.

Diagnóstico genético confirmado

PACIENTE REAL

M46

GENE

TMEM231

VARIANTE

c.710A>G · p.Y237C

ACMG

VUS no artigo; altamente compatível com fenótipo

DRC NO ARTIGO

Estágio 5 / falência renal aos 12 meses

Ponto didático

O diagnóstico sindrômico é guiado por malformações maiores convergentes em cílios primários.

Peter Parker · 7 anos

Hipótese clínica: Sensenbrenner / Senior-Løken — espectro cranioectodérmico-retinal-renal

Achados clínicos → hipótese → gene/variante



Menino, 7 anos · baixa estatura com fenótipo esquelético

Achados clínicos principais

- Esquelético: baixa estatura acentuada, rizomelia e metáfises/epífises irregulares
- Tórax: tórax estreito em sino, costelas curtas e padrão respiratório restritivo ao esforço
- Oftalmológico: nictalopia, perda periférica e retinopatia pigmentar
- Ectodérmico: cabelos finos/esparsos, unhas distróficas e anomalias dentárias/esmalte
- Desenvolvimento cognitivo típico; rins normais no momento no caso fictício

Padrão sindrômico

Fenótipo axial-esquelético + retina + ectoderma direciona para ciliopatia ligada ao transporte intraflagelar.

Diagnóstico genético confirmado

PACIENTE REAL

P18

GENE

WDR19

VARIANTE

c.3553G>A · p.R1178Q

ACMG

Provavelmente patogênica

DRC NO ARTIGO

Estágio 5 / falência renal aos 5 anos

Ponto didático

A nefropatia pode não dominar a apresentação inicial; monitoramento renal longitudinal é essencial.



Menino, 2a4m · atraso motor e respiração irregular

Achados clínicos principais

- Neurológico: hipotonia axial grave, ataxia, atraso motor e instabilidade postural
- Respiratório: alternância neonatal de taquipneia e apneia de padrão central
- Neuroimagem: hipoplasia do vermis e sinal do “dente molar” na RM axial
- Ocular: nistagmo/“olhar flutuante” e suspeita de baixa visão
- Renal: cistos córtico-medulares bilaterais e creatinina discretamente elevada

Padrão sindrômico

O sinal do dente molar ancora Joubert; associação com cistos renais amplia para ciliopatia sindrômica.

Diagnóstico genético confirmado

PACIENTE REAL

M48

GENE

TMEM138

VARIANTE

c.389A>G · p.Y130C

ACMG

Provavelmente patogênica

DRC NO ARTIGO

Estágio 1

Ponto didático

Quando RM + respiração central + nefropatia coexistem, priorizar genes de Joubert/ciliopatias renais.